

골다공증·골감소 — 운동·칼슘·비타민D

골다공증은 디스크와는 다른 병입니다. 뼈의 양과 강도가 줄어 부러지기 쉬워진 상태라 아프지 않아도 관리합니다.
운동·칼슘·비타민D가 기본이고, 필요하면 치료 주사·약을 함께 씁니다.

내 골밀도 T점수 읽는 법

T점수	판정
$T \geq -1.0$	정상
$-2.5 < T < -1.0$	골감소
$T \leq -2.5$	골다공증

나쁜 쪽이 내 성적 · MY SCORE

척추와 고관절 중 더 낮은 쪽으로 판정합니다.

폐경 전 여성과 50세 미만 남성은 다른 기준(Z점수)으로 봅니다.

내 결과는 척추·고관절 수치를 보고 진료 때 설명해 드립니다.

뼈는 무게를 받아야 강해집니다

이렇게 하세요 · DO

걷기 — 체중을 실는 운동의 시작입니다

앉았다 일어나기 — 다리 근력을 쓰는 운동

가벼운 점프 — 골절을 겪었다면 먼저 상의

강도는 천천히 — 걷기만보다 근육운동을 섞으면 더 좋습니다

피하세요 · DON'T

허리를 앞으로 숙이는 굴곡 운동 — 압박골절 위험

윗몸일으키기 · 요가의 깊이 숙이는 자세

무거운 물건을 든 채 허리 숙이기

골밀도가 낮을수록 숙이는 동작에 더 조심합니다

칼슘과 비타민D — 이렇게 채웁니다

무엇을	어떻게	기억할 것
칼슘 음식	우유·치즈·멸치·깻잎으로 먼저 채웁니다.	음식으로 모자랄 때만 보충제를 씁니다.
사골국·곰국	뼈에 좋다고 일부러 드시지 마세요.	사골국을 주된 칼슘 공급원으로 기대하기는 어렵습니다.
비타민D 수치	검사지 정상범위는 30~100(ng/mL) . 목표는 진료 때 정합니다.	한국 여성 대부분이 부족합니다.
먹는 비타민D	하루 1000IU 를 먹으면 약 10 오릅니다.	사람마다 오르는 폭이 다르니 다시 재 봅니다.
비타민D 주사	몇 달 간격으로 맞는 방법도 있습니다.	간격은 진료 때 정합니다.

흔한 오해 — 치료 주사·약은 끊으면 다시 떨어집니다

MYTH · MBP

"MBP 영양제로 뼈를 채운다"

작은 연구뿐이고, 골절 예방·치료제 대신은 입증되지 않았습니다.

MYTH · VITAMIN D

"비타민D만 먹으면 된다"

운동·칼슘이 함께 가야 하고, 필요하면 치료제를 씁니다.

MYTH · INJECTION

"주사가 먹는 약보다 순하다"

더 순한 약이 아닙니다. 특히 데노수맙은 끊으면 뼈가 빠르게 약해집니다.

FOLLOW-UP

"좋아졌으니 그만해도 된다"

임의로 끊지 마세요. 보험을 유지하려면 **1년마다 골밀도 검사**를 합니다.

이럴 때는 바로 진료 · SEE A DOCTOR

가벼운 충격·기침·물건 들기 뒤 갑자기 심한 허리·등 통증

데노수맙 주사 예정일을 놓쳤을 때 — 미루지 말고 연락

넘어진 뒤 엉덩이·사타구니가 아파 서거나 걷기 어려움 — 고관절 골절일 수 있어 응급실로

키가 줄거나 등이 굽어질 때

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한골대사학회 골다공증 진료지침 2024 · Clinician's Guide to Osteoporosis (PMID 35478046) · 폐경 후 운동 메타분석 (PMID 32785775) · 척추 굴곡 vs 신전 운동 (PMID 6487063) · 데노수맙 중단 ECTS 권고 (PMID 33103722, 40057981)

본 자료는 골다공증·골감소 관리를 위한 일반 안내입니다. 나이, 폐경 여부, 골절 경험, 복용 중인 약에 따라 운동 강도와 치료가 달라지니 진료 때 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/musculoskeletal/osteoporosis-lifestyle/

